

INFORME DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

— Variante Profesional —

PACIENTE

José Manuel Herrera Patiño

DOCUMENTO

CC 17012345

FECHA NACIMIENTO

18/06/1945

EDAD

81 años, 0 meses

SEXO

Masculino

ESCOLARIDAD

Bachiller Incompleto

LATERALIDAD

Diestro

FECHA DE EVALUACIÓN

20/06/2026

ORDEN N°

OM-2026-001250

PROTOCOLO APLICADO

Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + NPIQ

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

Nombre:	José Manuel Herrera Patiño	Lateralidad:	Diestro
Documento:	CC 17012345	Ocupación:	Pensionado
Fecha de nacimiento:	18/06/1945	Ciudad:	Bogotá, D.C.
Edad:	81 años, 0 meses	Acompañante:	Patricia Herrera Moreno
Sexo:	Masculino	Remite:	Neurólogo
Escolaridad:	Bachiller Incompleto	EPS / Asegurador:	Compensar EPS

MOTIVO DE CONSULTA

Deterioro cognitivo progresivo de 5 años. No reconoce familiares cercanos, vagabundeo, incontinencia ocasional. Antecedente de 2 ACV isquémicos. En tratamiento con donepecilo 10 mg.

PRUEBAS APLICADAS

Protocolo: Neuronorma Colombia AM + MMSE + GDS-15 + NPIQ

Prueba	Dominio	Dur.
TMT A	Atención	—
TMT B	Funciones Ejecutivas	—
Span Retención Dígitos Directo	Memoria de Trabajo	—
Span Retención Dígitos Inverso	Memoria de Trabajo	—
Test de Stroop Palabra	Atención	—
Test de Stroop Color	Atención	—
Test de Stroop Palabra/Color	Atención	—
Fluidez Verbal Animales	Lenguaje - Fluidez	—
Fluidez Verbal Fonémica (P)	Lenguaje	—
AM Deno	Lenguaje	—
Grober RL Ensayo 1 (libre)	General	—
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	General	—
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	General	—
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	Socioemocional - Depresión	—
Mini-Mental State Examination (MMSE)	General	—
Escala de Lawton y Brody (IADL)	General	—

ANTECEDENTES

Patológicos / Médicos

Sin antecedentes médicos de relevancia.

Farmacológicos

Sin medicación actual.

Familiares

Sin antecedentes neuropsiquiátricos de primer grado.

Psiquiátricos

Antecedente de trastorno depresivo en tratamiento con sertralina 50 mg/día.

Traumáticos

Niega TEC.

RESUMEN EJECUTIVO

Pirámide invertida: conclusión, hallazgos, implicación

Conclusión

Perfil neuropsicológico global: $Z = -1.6\sigma$ sobre 5 dominios evaluados.

Hallazgos clave

- Lenguaje - Fluidez severamente descendido ($Z = -2.0\sigma$)

Implicación

Se recomienda intervención prioritaria en el dominio con mayor descenso, con seguimiento cercano de la evolución.

OBSERVACIÓN CLÍNICA

Hallazgos cualitativos durante la administración

Apariencia y conducta

Evaluación neuropsicológica completa. Paciente colaborador. Sin incidentes durante la aplicación.

Memoria

Déficit severo en memoria anterógrada y retrógrada. No recuerda hechos biográficos recientes. Reconoce a cuidadora primaria.

Praxias y gnosias

Sin alteraciones significativas en praxias ni gnosias.

Lenguaje

Lenguaje empobrecido. Parafasias semánticas frecuentes. Comprensión de órdenes simples. Sin discurso espontáneo fluido.

Cociente intelectual (observación)

Perfil cognitivo global: F03 - Demencia mixta (Alzheimer + vascular)

RESULTADOS CUANTITATIVOS

Puntajes por prueba y perfil cognitivo del paciente

Escala de Depres

7

Deficit Leve

Mini-Mental Stat

14

Deficit Extremo

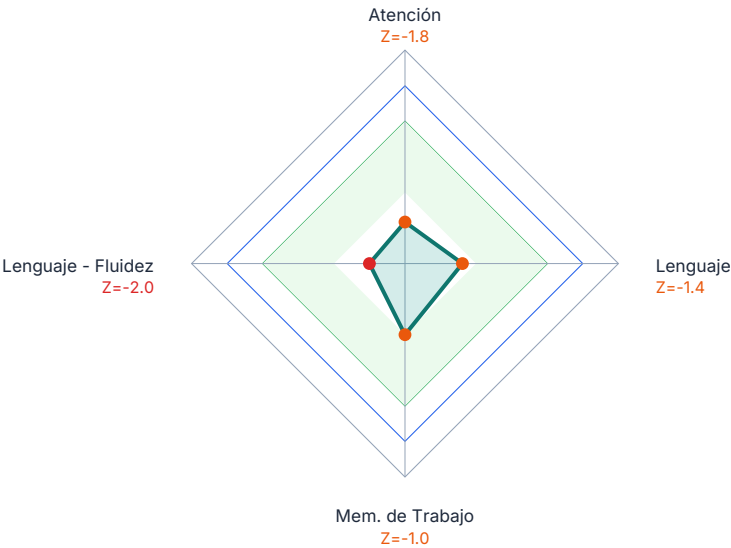
Escala de Lawton

2

Deficit Severo

Perfil cognitivo por dominio

Cada eje representa un dominio cognitivo. El polígono teal muestra el Z del paciente; la franja verde central equivale al rango normal (-1 a +1 σ).

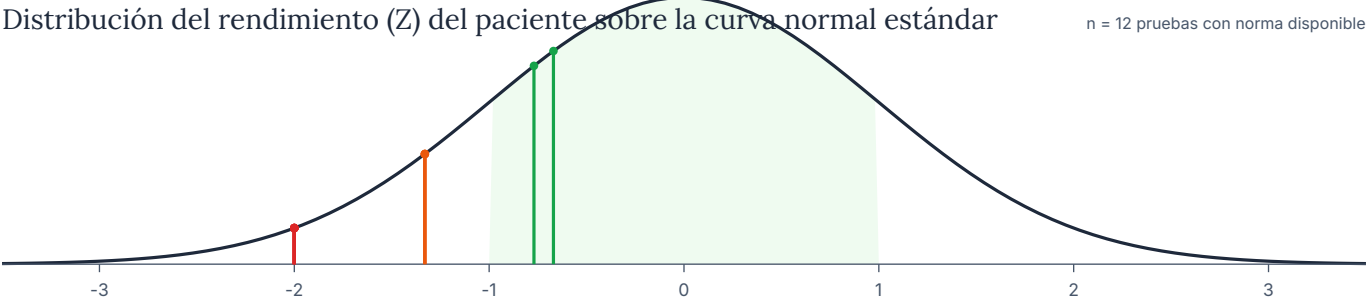


Curva normal con puntajes Z del paciente

Eje horizontal: puntaje Z (unidades de desviación estándar). Las marcas rojas son los puntajes del paciente sobre la curva.

Distribución del rendimiento (Z) del paciente sobre la curva normal estándar

n = 12 pruebas con norma disponible



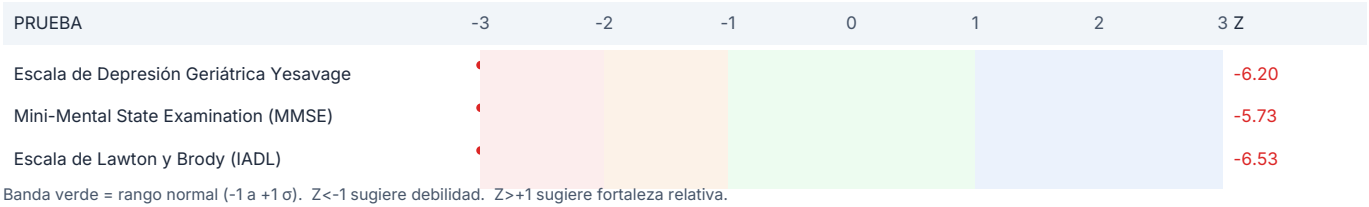
Perfil Z por prueba

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
--------	----	----	----	---	---	---	-----

Perfil Z por prueba

Eje horizontal: puntaje Z (rango -3 a +3). Verde = zona normal; rojo/naranja = debajo del promedio; azul = por encima.

PRUEBA	-3	-2	-1	0	1	2	3 Z
TMT A							-1.33
Span Retención Dígitos Directo							-1.33
Span Retención Dígitos Inverso							-0.67
Test de Stroop Palabra							-2.00
Test de Stroop Color							-2.00
Test de Stroop Palabra/Color							-2.00
Fluidez Verbal Animales							-2.00
Fluidez Verbal Fonémica (P)							-2.00
AM Deno							-0.77
Grober RL Ensayo 1 (libre)							-2.00
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)							-1.33
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)							-2.00



Semáforo de dominios cognitivos

DOMINIO	Z	BANDA
Lenguaje - Fluidez	-2.00σ	severo
Atención	-1.83σ	moderado
General	-1.78σ	moderado
Lenguaje	-1.39σ	moderado
Memoria de Trabajo	-1.00σ	moderado

Tabla detallada de puntajes

Prueba	PD	Escalar/CI	Z	Interpretación
TMT A	250	6	-1.33	Limitrofe
TMT B	—	—	—	Sin dato
Span Retención Dígitos Directo	3	6	-1.33	Limitrofe
Span Retención Dígitos Inverso	1	8	-0.67	Promedio
Test de Stroop Palabra	22	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Color	18	4	-2.00	Bajo
Test de Stroop Palabra/Color	5	4	-2.00	Bajo
Fluidez Verbal Animales	5	4	-2.00	Bajo
Fluidez Verbal Fonémica (P)	2	4	-2.00	Bajo
AM Deno	22	22	-0.77	Limitrofe
Grober RL Ensayo 1 (libre)	2	4	-2.00	Bajo
Grober RLT - Retención Libre Total (E1+E2+E3)	2	6	-1.33	Limitrofe
Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3)	4	4	-2.00	Bajo
Escala de Depresión Geriátrica Yesavage	7	7	-6.20	Deficit Leve
Mini-Mental State Examination (MMSE)	14	14	-5.73	Deficit Extremo
Escala de Lawton y Brody (IADL)	2	2	-6.53	Deficit Severo

SÍNTESIS CLÍNICA INTEGRADORA

Lectura cuantitativa de los hallazgos

El perfil neuropsicológico evidencia debilidades en: lenguaje - fluidez (severamente disminuido, Z=-2.0); atención (moderadamente disminuido, Z=-1.8); general (moderadamente disminuido, Z=-1.8); lenguaje (moderadamente disminuido, Z=-1.4); memoria de trabajo (moderadamente disminuido, Z=-1.0).

Entre las pruebas con mayor desviación se encuentran Test de Stroop Palabra (Z=-2.00, bajo); Test de Stroop Color (Z=-2.00, bajo); Test de Stroop Palabra/Color (Z=-2.00, bajo). Estos hallazgos orientan la formulación diagnóstica y la priorización de objetivos de intervención.

Áreas con desempeño disminuido

- Fluidez Verbal Animales — bajo ($Z=-2.00$)
- Fluidez Verbal Fonémica (P) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RL Ensayo 1 (libre) — bajo ($Z=-2.00$)
- Grober RT - Recuerdo Total Claves (E1+E2+E3) — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Color — bajo ($Z=-2.00$)
- Test de Stroop Palabra — bajo ($Z=-2.00$)

RESUMEN PARA LA FAMILIA

Lenguaje sencillo para padres, cuidadores y paciente

Saludo

Este es un resumen de la evaluación que se realizó José. Está escrito en un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. Tu psicólogo o psicóloga te explicará los detalles y resolverá cualquier duda que tengas.

¿Qué hicimos en la evaluación?

Realizamos varias pruebas que miden cómo funciona tu cerebro en distintas situaciones: memoria, atención, lenguaje, razonamiento y la velocidad con la que procesas información. Las pruebas son como "pequeños retos" que se resuelven con papel, lápiz y a veces con cubos o figuras. No hay respuestas buenas ni malas: lo que nos interesa es conocer cómo trabaja tu mente.

¿Qué encontramos?

Las áreas donde te fue bien incluyen: En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado. Las áreas donde se recomienda trabajar incluyen: En TMT A, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca. En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

Implicaciones para la vida diaria

Además de los puntajes, esto es lo que podría notarse en la vida cotidiana:

Lenguaje - Fluidez · severo

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Atención · moderado

- Mantener el foco en una conversación larga (especialmente en reuniones o clases).
- Seguir instrucciones de varios pasos sin perder algún detalle.
- Filtrar estímulos distractores en lugares ruidosos o con mucha gente.

Apoyos sugeridos: Dividir el trabajo en bloques de 20-25 minutos con pausas activas. · Usar temporizadores visuales (Time Timer) y listas de verificación.

General · moderado

- Tareas que dependen de esta función pueden requerir más esfuerzo o tiempo.
- Rendimiento bajo comparado con pares de la misma edad y escolaridad.

Apoyos sugeridos: Practicar con constancia y paciencia. · Acompañar el proceso con apoyo profesional y familiar.

Lenguaje · moderado

- Encontrar la palabra exacta cuando se necesita (lo que se llama 'tener la palabra en la punta de la lengua').
- Comprender textos largos, abstractos o con doble sentido.
- Explicar ideas complejas de forma ordenada.

Apoyos sugeridos: Practicar lectura activa: subrayar, resumir, explicar en voz alta. · Juegos de palabras: crucigramas, sopas de letras, scrabble, narraciones.

Áreas para apoyar (en qué trabajar)

- En Span Retención Dígitos Inverso, tu rendimiento fue dentro del rango esperado.
- En TMT A, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Span Retención Dígitos Directo, tu rendimiento estuvo en el límite (Límitrofe). Vale la pena acompañarlo de cerca.
- En Test de Stroop Palabra, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.
- En Test de Stroop Palabra/Color, encontramos un rendimiento por debajo del promedio. Es importante que converses con tu psicólogo/a sobre qué significa esto y qué apoyos podrían ayudarte.

¿Qué recomendamos?

Sobre la terapia: continúa con tus sesiones según lo acordado. Si tienes dudas, coméntalas con tu terapeuta.

Preguntas frecuentes

¿Mis resultados son permanentes?

No necesariamente. El cerebro puede cambiar con el tiempo, especialmente con práctica, con los apoyos adecuados y con un buen ambiente. Estos resultados son una foto del momento actual: tu psicólogo/a te ayudará a entender qué puede cambiar y qué se mantiene más estable.

¿Por qué algunos resultados son mejores que otros?

Es completamente normal. Todas las personas tienen áreas donde son más fuertes y áreas donde pueden mejorar. Esto NO significa que haya algo mal: el cerebro humano es diverso y cada uno tiene su propio perfil.

¿Qué significa un puntaje 'bajo' o 'muy bajo'?

Significa que, comparado con personas de la misma edad y nivel educativo, esa función específica rindió por debajo de lo esperado. NO es un diagnóstico en sí mismo. Es una señal para profundizar, entrenar y apoyar esa área. Tu psicólogo/a te explicará si requiere intervención profesional adicional.

¿Qué es el 'cociente intelectual' (CI)?

El CI es un número que resume el rendimiento global en diversas pruebas. NO define tu inteligencia total ni tu valor como persona: es solo una medida parcial de ciertas habilidades de razonamiento, memoria y atención. Varía según el contexto, la fatiga, el ánimo del día y muchos otros factores.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA

DSM-5 / CIE-10

Diagnóstico codificado

Código CIE-10: F03

Impresión diagnóstica: F03 - Demencia mixta (Alzheimer + vascular)

RECOMENDACIONES

Plan de manejo agrupado por área y prioridad

- Se recomienda seguimiento clínico y plan terapéutico según hallazgos. Reevaluación en 6-12 meses si aplica.